

УДК: 616.34-006.6-089:616-036.22

Д.А.Тулесуова, Г.А.Серикбаев, Ж.О.Мауленов, А.А.Исалиев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Криотерапия как метод лечения больных местнораспространенным раком кожи

Аннотация. Злокачественные заболевания кожи составляют около 25% всех злокачественных опухолей и в течение многих лет стабильно занимают 3-4 место среди онкологических заболеваний. С 2002 по 2010 гг. в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР проведено криогенное лечение 500 больным местнораспространенным базальноклеточным и метатипичным раком.

Ключевые слова: рак кожи, криотерапия.

Неуклонный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи во всем мире называют «тихой» эпидемией. Злокачественные заболевания кожи составляют около 25% всех злокачественных опухолей и в течение многих лет стабильно занимают 3-4 место среди онкологических заболеваний [1].

Базальноклеточный рак — самая распространенная злокачественная опухоль кожи и встречается в 88,4% случаев. Другие виды рака кожи (плоскоклеточный, метатипический, малигнизировавшаяся кератоакантома, болезнь Боуэна) — это редкие опухоли. До 86,1% рак кожи локализуется на открытых частях тела — кожи лица и шеи [2, 3].

Базальноклеточный рак кожи не дает метастазов, однако является рецидивирующей опухолью после всех видов лечения, и глубоко разрушающей местные ткани. В 10—20% случаев имеет множественный характер [4].

Известны три метода лечения рака кожи: лучевая терапия, оперативное лечение и криодеструкция. Все перечисленные методы лечения не гарантируют 100%-го излечения опухоли.

Криодеструкция опухоли имеет преимущество перед лучевым и оперативным методом из-за хорошего онкологического и косметического результатов, возможности повторять криодеструкции неоднократно при рецидивах или местном распространении опухоли всем больным, даже пациентам со старческой дряхлостью или отягощенным соматическими заболеваниями [5,6].

С 2000 по 2008 гг. в отделении опухолей костей и мягких тканей КазНИИОиР проведено криогенное лечение 500 больным местнораспространенным базальноклеточным и метатипичным раком кожи головы в возрасте от 25 до 92 лет, в том числе при распространенности опухоли соответственно Т1 — у 150 больных, Т2 — у 272 больных, Т3 — у 75 больных и Т4 — у 3 больных. Из них 30 больных с рецидивом опухоли кожи после лучевой терапии и оперативного лечения. Сроки наблюдения составили 1-8 лет.

Одним из важнейших критериев определения показаний к криогенному лечению является размеры опухоли от 0,5 до 8,0 см в диаметре и отсутствие прорастания в мышечные ткани и кости, а также пациенты с отягощенными сопутствующими заболеваниями.

Метод основан на некрозе опухоли в результате замораживания

ткани жидким азотом температурой кипения –196°С. В результате такого воздействия полностью разрушается опухолевая ткань, активизируются защитные факторы, тормозящие дальнейшее развитие опухоли. Лечение проводится аппаратом КАС – 01 и в зависимости от стадии заболевания курс составляет от 1 до 10 сеансов. Сеанс длится в течение 15-20 минут, основанный на чередовании замораживания и оттаивания опухоли. Граница планируемой зоны криодеструкции должна выходить не менее, чем на 0,5-1,0 см за границы опухоли, т.е. захватывать прилежащие здоровые ткани. Криогенный способ лечения позволяет максимально сберечь местные ткани и органы, что особенно важно при локализации опухоли на лице.

После применения криотерапии, рана оставляется открытой для самостоятельного заживления (вторичным натяжением). В месте лечебного воздействия в норме возможно образование пузыря, появление выделений и формирование струпа. Заживление длится 2-5 недель. Осложнения наблюдаются редко и включают нагноение под струпом, гипертрофические рубцы, повреждение нервов.

Контроль радикальности осуществляется через 1 месяц после лечения, после полного выпадения струпа, а у больных, ранее получавшие лучевую терапию, период заживления удлинняется до 2 месяцев.

Больные в большинстве случаев трудоспособны.

Отдаленные результаты, прослежены у 415 больных в сроки от 4 мес. до 8 лет. Рецидивы выявлены у 33 (8%) больных, в связи с чем проводилось хирургическое или криогенное лечение. Появление рецидивов чаще наблюдаются в основном при локализации опухоли в волосистой части головы в Т3 стадии при прорастании в поверхностную фасцию.

Выводы: криотерапия позволяет полностью разрушить заданный объем ткани на поверхности тела, малоболезненна, абластична, обладает гемостатическим эффектом, малая травматичность метода, кратковременность операции и отсутствие необходимости во многих случаях проводить медикаментозную анестезию, существенно расширяют круг пациентов, для которых другие хирургические операции противопоказаны и криохирургический метод оказывается для них единственно возможным (например, для лиц преклонного возраста, с повышенной чувствительностью к медикаментам и т.п.) и обеспечивает вполне удовлетворительный косметический эффект без грубых рубцов. Возможно проведение многократных повторных циклов воздействия, относительно безопасна и просто выполняема [5,7]. Расширяет возможности радикального лечения, а также возможна иммунная реакция организма против выживших или рецидивных злокачественных клеток.

Список литературы

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2002 г. ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. — М.: Медицинское информационное агентство, 2004.
2. Ламоткин И.А. Опухоли и опухолеподобные поражения кожи. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — С. 7-51.
3. Nikolai Korpa (ed.), «Basics of Cryosurgery», Springer-Verlag/-Wien, 2001.
4. Афанасьева Н.И., Шевцов В.Г. и соавт. «Перспективы применения криохирургии в онкологии» //Международный медицинский журнал. -2002.- №1.
5. Демидов Л.В., Харкевич Г.Ю., Маркина Г.И. и соавт. Меланома и другие злокачественные новообразования кожи // Энциклопедия клинической онкологии. — М., 2004. — С. 341-355.
6. Кудрявцева Г.Т., Рожнова Е.Н. Непосредственные и ближайшие результаты лечения рака кожи в зависимости от метода лечения // Тезисы II съезда онкологов СНГ. — Киев, 2000. — С. 802.
- 6.7. Отченаш Н.Н., Дудниченко А.С., Гончаров В.И., Садчикова М.В., Использование физических методов воздействия при лечении немеланомного рака кожи // Тезисы III съезда онкологов СНГ. — Минск, 2004. — Т. 2 — С. 282.

Тұжырым

Д.А.Тулеуова, Г.А.Серикбаев, Ж.О.Мауленов, А.А.Исалиев

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Қатерлі теріісігі, барлық қатерлі ісікауруларының 25% (жиырма бес) пайызына жуығын құрайды, қатерлі ісік ауруларының ішінде көп жылдар бойы тұрақты 3-4 орынды алып турған. 2000мен 2008 жылдар аралығында К.А3F30 және РІнің сүйек және жұмсақ тіндер ісігі бөлімшесінде 500ге жуық жергілікті таралған базальді клетка және метатиптітері мен бас ісігі науқастарына киогеппді ем жүргізілген.

Түйінді сөздер: тері қатерлі ісігі, криотерапия.

Summary

D.A. Tuleuova, G.A. Serikbaev, Zh.O.Maulenov, A.A. Isaliev

Kazakh Scientific Institute Oncology and Radiology

Malignant tumors of skin make up about 25 % of all malignant tumors and take consistently the third place among all cancers for many years. Cryodestruction of the tumor has an advantage over radiation and surgical methods because of the good oncological and cosmetic results. Also cryodestruction repetition with relapses or local tumor spreading to all patients is able, even patients with senile senility or patients with aggravated by systemic diseases. It has been treated 500patients with base- cttlular cancer and metatypical head of skin cancer at the age of 25 to 92 years.

Keywords: skin cancer, cryotherapy.